

Anatomie Topographique de la Région Axillaire

Durée : 30 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Creux axillaire, Aisselle, Artère axillaire, Veine axillaire, Plexus brachial, Noeuds lymphatiques axillaires, Anatomie topographique

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire la forme générale de la région axillaire (pyramide quadrangulaire) et situer ses limites.
- ▶ Identifier les muscles et les structures osseuses qui constituent les quatre parois, le sommet et la base de la pyramide axillaire.
- ▶ Lister les principaux éléments vasculo-nerveux qui traversent la région axillaire.
- ▶ Décrire l'organisation de la gaine axillaire contenant l'artère, la veine et les faisceaux du plexus brachial.
- ▶ Expliquer l'importance clinique des noeuds (ganglions) lymphatiques axillaires, notamment dans le drainage du sein.

Introduction et Contexte Scientifique

La région axillaire, plus communément appelée creux axillaire ou aisselle, est une région anatomique complexe située à la jonction entre le membre supérieur et le tronc. Elle a la forme d'une **pyramide quadrangulaire** tronquée, dont la base est cutanée et le sommet communique avec la région cervicale. Loin d'être un espace vide, le creux axillaire est une voie de passage cruciale pour toutes les structures vasculo-nerveuses majeures destinées au membre supérieur : l'**artère axillaire**, la **veine axillaire**, et les troncs secondaires puis les faisceaux du **plexus brachial**. Elle contient également de nombreux noeuds lymphatiques, qui drainent la lymphe du membre supérieur et d'une grande partie de la paroi thoracique, y compris de la glande mammaire. Sa connaissance est donc essentielle en traumatologie, en anesthésie locorégionale et en cancérologie mammaire.

1. Les Limites de la Pyramide Axillaire

La région axillaire est décrite comme une pyramide dont la base est en bas et le sommet en haut et en dedans.

La Base

Elle est superficielle, formée par la **peau** et le **fascia axillaire** (fascia profond tendu entre les muscles grand pectoral et grand dorsal). C'est la partie concave que l'on palpe.

Le Sommet (Apex)

Il est profond et correspond à un défilé ostéo-musculaire appelé **canal cervico-axillaire**. C'est par là que les structures vasculo-nerveuses pénètrent dans l'aisselle. Il est délimité par :

- **En avant** : Le bord postérieur de la **clavicule**.
- **En arrière** : Le bord supérieur de la **scapula**.
- **En dedans** : Le bord latéral de la **première côte**.

La Paroi Antérieure

Elle est musculaire et formée par :

- Le muscle **grand pectoral** (superficiel).
- Le muscle **petit pectoral** et le muscle **subclavier**, situés dans un plan plus profond et enveloppés par le fascia clavi-pectoral.

La Paroi Postérieure

Elle est également musculo-osseuse :

- Le muscle **subscapulaire** (qui recouvre la face antérieure de la scapula).
- Le muscle **grand rond** (plus bas).
- Le muscle **grand dorsal** (latissimus dorsi), qui forme le relief postérieur de l'aisselle.

La Paroi Médiale (Interne)

Elle est formée par la paroi thoracique latérale :

- Les **quatre ou cinq premières côtes** et les muscles intercostaux.
- Le muscle **dentelé antérieur** (serratus anterior) qui plaque la scapula contre le thorax. Le nerf thoracique long chemine à sa surface.

La Paroi Latérale (Externe)

Elle est étroite et osseuse, formée par :

- La **gouttière intertuberculaire de l'humérus** (sillon bicipital).
- Les muscles **coraco-brachial** et **biceps brachial**.

2. Le Contenu de la Région Axillaire

Les éléments nobles du creux axillaire sont contenus dans une gaine fibro-graisseuse.

Les Éléments Vasculo-Nerveux

Ces structures sont regroupées dans un 'paquet' vasculo-nerveux, lui-même entouré par une extension du fascia cervical appelée la **gaine axillaire**.

- **L'artère axillaire** : C'est l'élément central du paquet. Elle fait suite à l'artère subclavière au niveau du bord latéral de la 1^{ère} côte et devient l'artère brachiale au niveau du bord inférieur du muscle grand rond.
- **La veine axillaire** : Elle est située en dedans et en avant de l'artère. Elle se forme par la réunion des veines brachiales et de la veine basilique, et devient la veine subclavière au bord latéral de la 1^{ère} côte.
- **Le plexus brachial** : Ce réseau nerveux issu des racines C5 à T1 innerve le membre supérieur. Dans la région axillaire, il est organisé en **troncs secondaires ou faisceaux** (latéral, médial, postérieur) qui s'organisent de manière caractéristique autour de l'artère axillaire, lui donnant leur nom. Ces faisceaux donneront ensuite naissance aux nerfs terminaux du bras (nerfs musculo-cutané, médian, ulnaire, radial, axillaire...).

Les Noeuds (Ganglions) Lymphatiques Axillaires

Ils sont très nombreux (20 à 40) et répartis dans le tissu adipeux de la région. Ils sont organisés en plusieurs groupes :

- **Groupe Pectoral (ou antérieur)** : Le long de la paroi antérieure. Draine la majeure partie de la glande mammaire.
- **Groupe Subscapulaire (ou postérieur)** : Le long de la paroi postérieure.
- **Groupe Huméral (ou latéral)** : Le long de la veine axillaire. Draine la quasi-totalité du membre supérieur.
- **Groupe Central** : Au centre de la pyramide, recevant la lymphe des trois groupes précédents.
- **Groupe Apical** : Au sommet de la pyramide. Il reçoit la lymphe du groupe central et se draine dans les troncs subclaviers.

3. Rapports et Intérêt Clinique

Organisation du Paquet Vasculo-Nerveux

À l'intérieur de la gaine axillaire, les faisceaux du plexus brachial s'organisent autour du deuxième segment de l'artère axillaire (en arrière du muscle petit pectoral) :

- Le **faisceau latéral** est en dehors de l'artère.
- Le **faisceau médial** est en dedans de l'artère.
- Le **faisceau postérieur** est en arrière de l'artère.
- La **veine axillaire** est en dedans et en avant du paquet.

Importance Clinique

- **Anesthésie locorégionale** : Le bloc du plexus brachial par voie axillaire est une technique courante pour anesthésier le membre supérieur en injectant un anesthésique local dans la gaine axillaire.
- **Traumatologie** : Les luxations de l'épaule peuvent léser les éléments du creux axillaire, notamment le nerf axillaire (qui contourne le col chirurgical de l'humérus) et l'artère axillaire.
- **Cancérologie** : Les noeuds lymphatiques axillaires sont le premier relais de drainage de la plupart des cancers du sein. Leur atteinte (métastase ganglionnaire) est un facteur pronostique majeur. Le **curage axillaire** (exérèse chirurgicale des ganglions) ou la technique du **ganglion sentinelle** font partie intégrante du traitement chirurgical du cancer du sein.
- **Palpation** : Le pouls de l'artère axillaire peut être palpé contre l'humérus. La palpation des groupes ganglionnaires est un temps essentiel de l'examen clinique, notamment des seins.

À Retenir

- La région axillaire a la forme d'une pyramide quadrangulaire, dont les parois sont formées par les muscles pectoraux (avant), subscapulaire/grand dorsal (arrière), dentelé antérieur (médial) et l'humérus (latéral).
- Elle constitue une voie de passage pour le paquet vasculo-nerveux du membre supérieur, contenu dans la gaine axillaire.
- Ce paquet contient l'artère axillaire, la veine axillaire et les faisceaux du plexus brachial, qui s'organisent de façon précise autour de l'artère.
- Le creux axillaire abrite de nombreux noeuds lymphatiques organisés en plusieurs groupes (pectoral, subscapulaire, huméral, central, apical).
- La connaissance de cette région est cruciale en cancérologie mammaire (drainage lymphatique), en traumatologie (luxation d'épaule) et en anesthésie (bloc du plexus brachial).

Bibliographie Courte

- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
- [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
- [3] Kamina P. Anatomie Clinique, Tome 1 : Anatomie générale, membres. 5e édition. Maloine, 2015.